



RECOMENDAÇÕES DA SPG SUAS SECÇÕES E NÚCLEOS DE INTERESSE PARA TRIAGEM DE PACIENTES COM PATOLOGIA GINECOLÓGICA E DA MAMA NO CONTEXTO DA PANDEMIA POR SARS-CoV-2

Este documento teve revisão e aprovação das Direções dos Colégios da Especialidade de Ginecologia e Obstetrícia e de Ginecologia Oncológica da Ordem dos Médicos.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1. No contexto actual de pandemia por Sars-CoV-2 é consensual que todas as cirurgias electivas não urgentes devem ser adiadas
2. Na admissão de doentes para cirurgia programada deverá realizar-se uma avaliação clínica para identificação de sintomas e sempre que possível, deve efetuar-se a colheita para teste de identificação de SARS-CoV-2.
3. Estas recomendações têm como objetivo servir de orientação, salvaguardando que a decisão final deve ser tomada num contexto multidisciplinar, considerando a opinião de outras especialidades, nomeadamente anestesiologia e as condições particulares de cada instituição em que os procedimentos sejam efetuados.

CIRURGIAS GINECOLÓGICAS URGENTES (NÃO ADIÁVEIS)

1. Abscesso tubo-ovárico que não responde a tratamento conservador;
2. Torsão anexial;
3. Rotura de cisto hemorrágico/folículo com repercussão hemodinâmica;
4. Hemorragia uterina aguda que não cede ao tratamento médico;
5. Outras hemorragias genitais importantes e impossíveis de tratar com tratamento expectante;
6. Gravidez ectópica sem critérios para tratamento médico ou expectante;

CIRURGIAS GINECOLÓGICAS CUJO ADIAMENTO PODE AGRAVAR SIGNIFICATIVAMENTE O PROGNÓSTICO DA DOENTE

A todos os que tratam cancro ginecológico recomenda-se a consulta das recomendações da ESGO/IGCS e da SGO.



Sociedade Portuguesa de Ginecologia

SPCPTGI, SPEG, SPGO, SPM, SPUG



European Society of Gynaecological Oncology (ESGO) / International Gynecologic Cancer Society (IGCS)¹

Society of Gynecologic Oncology (SGO)²

De um modo geral, entende-se ser razoável esperar até 8 semanas se o risco de exposição ao Covid 19 for considerado alto, sobretudo para cirurgias com maior potencial de complicações intra e pós-operatórias (necessidade de hemoderivados ou cuidados intensivos). Propõe-se, no entanto, reavaliação a cada 2 a 3 semanas.

No entanto, em termos oncológicos não se pode afirmar ser seguro adiar o procedimento.

Tem de se avaliar o período já decorrido desde o diagnóstico e a disponibilidade de bloco operatório no momento em cada hospital, bem como as comorbilidades de cada doente.

Reforça-se a necessidade de decisão multidisciplinar.

Recomenda-se a restrição das consultas presenciais de vigilância, favorecendo-se o contacto telefónico, deixando a realização de análises e exames de imagem apenas para os doentes sintomáticos.

Cancro do colo operável:

As ESGO/IGCS considera espera de 6 a 8 semanas desde o diagnóstico, se o acesso à cirurgia estiver limitado.

A SGO classifica como semi-urgente, a realizar entre 1 a 4 semanas.

Cancro do endométrio (critérios de risco referidos nas 2 recomendações)

Baixo risco: considerar tratamento hormonal, dispositivo de libertação intrauterino com levonorgestrel (52mg)

Alto risco: a ESGO/IGCS considera a possibilidade de realizar apenas Histerectomia total+anexectomia bilateral±biópsia gânglio sentinela (HT+AB ±BGS); a SGO classifica a cirurgia como semi-urgente, 1 a 4 semanas.



Cancro do Ovário

Possibilidade de iniciar quimioterapia neoadjuvante (QTNA) nas situações que requerem cirurgia de grande complexidade

A ESGO/IGCS considera a hipótese de estender a QTNA até 6 ciclos. A SGO classifica a cirurgia de intervalo após QTNA como semi-urgente, 1 a 4 semanas.

Cancro da vulva

A ESGO/IGCS é omissa. A SGO classifica a cirurgia como semi-urgente, 1 a 4 semanas.

Cancro da mama

Recomenda-se consulta das seguintes orientações:

American Society of Breast Surgeons ³

American College of Surgeons ⁴

A cirurgia deve ser considerada urgente/semi-urgente nos seguintes casos (1 a 4 semanas:

1. Cancro da Mama classificado como cT2 ou cN1 com RE+, RP+ e HER2-*;
2. Cancro da mama triplo negativo ou HER2+**;
3. Pós-tratamento com QTNA, em data ótima para cirurgia;
4. Biópsias discordantes com elevada probabilidade de malignidade;
5. Cirurgia de recidiva.

*algumas doentes podem receber hormonoterapia - discussão multidisciplinar

**algumas doentes podem começar por QTNA - discussão multidisciplinar

A cirurgia que deve ser diferida:

1. Cirurgia para alargamento de margens;
2. Cancros da mama cTis N0, RE + ou -;
3. Cancros da mama cT1N0, RE+, RP+, Her2- *;
4. Cirurgia de reconstrução da mama com tecidos autólogos;

*Estas doentes podem receber hormonoterapia - discussão multidisciplinar



CIRURGIAS GINECOLÓGICAS QUE PODEM SER ADIADAS POR ALGUMAS SEMANAS SEM IMPACTO SIGNIFICATIVO NA EVOLUÇÃO DA DOENÇA

1. Histeroscopia ou biópsia endometrial nas situações de hemorragia uterina anormal associadas a suspeição de neoplasia (clínica ou ecográfica);
2. Situações de patologia do tracto genital inferior (ver recomendações da SPCTGI);

CIRURGIAS GINECOLÓGICAS QUE PODEM SER ADIADAS POR VÁRIOS MESES

1. Histeroscopia ou biópsia endometrial nas situações de hemorragia uterina anormal sem suspeição de neoplasia (clínica ou ecográfica);
2. Situações de patologia do tracto genital inferior (ver recomendações da SPCTGI);
3. Cirurgias por patologia ginecológica benigna (miomectomia, massas anexiais não suspeitas, endometriose pélvica, histerectomia);
4. Esterilização definitiva;
5. Cirurgia de prolapso de órgãos pélvicos e correção de incontinência urinária;
6. Procedimentos ginecológicos do foro estético/cosmético;

VIA DE ABORDAGEM PARA A CIRURGIA GINECOLÓGICA NESTE CONTEXTO

No que diz respeito á abordagem laparoscópica a SPEG como Sociedade Afiliada da ESGE⁵ (European Society for Gynaecological Endoscopy), partilha as recomendações emitidas por esta Sociedade e enfatiza que:

1. Em todas as doentes, mas particularmente nos doentes Covid positivos ou em que não seja possível testar, a opção pela via laparoscópica deve ser discutida em equipa incluindo os anestesiolistas. Na decisão devem também ser consideradas as vantagens da abordagem para o doente e para o sistema de saúde nomeadamente pela menor morbilidade cirúrgica e pela redução do tempo de internamento.
2. Quando se opte pela abordagem laparoscópica devem ser adotadas todas as medidas que minimizem as fugas de CO₂ assim como devem ser usados



Sociedade Portuguesa de Ginecologia

SPCPTGI, SPEG, SPGO, SPM, SPUG



sistematicamente filtros apropriados para impedir a passagem de aerossóis com agentes patogénicos ou suas partículas.

3. Nas cirurgias em que se preveja envolvimento intestinal como por exemplo nos abscessos tubo-ováricos é aconselhada a laparotomia.

NOTA IMPORTANTE: Estas recomendações podem ser revistas e actualizadas de forma a incorporar as informações e normas de atuação nacionais ou internacionais mais recentes.

Bibliografia

1. <http://dx.doi.org/10.1136/ijgc-2020-001419>
2. <https://www.sgo.org/clinical-practice/management/covid-19-resources-for-health-care-practitioners/gyn-onc-considerations-during-covid-19/>
3. <https://www.breastsurgeons.org/>
4. <https://www.facs.org/>
5. <https://esge.org/wp-content/uploads/2020/03/Covid19StatementESGE.pdf>